Trabajo de parto y RCTG

Trabajo de parto y RCTG: datos de memoria para el ECOE

Fuentes: - **Trabajo de parto:** - Williams Obstetricia, cap. 22 *Trabajo de parto normal*. - GPC CENETEC 2019, *Vigilancia y atención amigable en el trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo*. - OMS 2018, *Intrapartum care for a positive childbirth experience*. - **RCTG:** - UpToDate, *Intrapartum category I, II and III FHR tracings: Management* y *Intrapartum FHR monitoring: Overview*. - ACOG Practice Bulletin 106 y consenso NICHD 2008.

PARTE 1. TRABAJO DE PARTO

1. Definiciones básicas

- **Trabajo de parto:** contracciones uterinas regulares que producen borramiento y dilatación cervical progresivos.
- **Diferencia entre trabajo de parto verdadero y falso:** el verdadero produce **cambio cervical**. Las contracciones son regulares, aumentan en frecuencia e intensidad y no ceden con el reposo.
- **Ingreso a sala de labor:** a partir de la **fase activa**. Antes de eso, la paciente se vigila de forma ambulatoria si no tiene riesgo.

2. Orientación fetal

Concepto	Definición	Lo normal
Situación	Relación del eje longitudinal fetal con el materno	Longitudinal (> 99 %)
Presentación	Parte fetal que se aboca al estrecho superior	Cefálica de vértice (~95 %)
Actitud	Relación de las partes fetales entre sí	Flexión
Posición	Relación del punto toconómico con el lado materno	Occipito izquierda anterior (OIA) es la más frecuente

Puntos toconómicos: - Vértice: **occipucio**. - Cara: **mentón**. - Frente: **naso** (o bregma). - Pélvica: **sacro**. - Hombro: **acromion**.

3. Maniobras de Leopold

1. **Primera:** palpar el fondo uterino para saber qué polo lo ocupa. Da la situación y la presentación.
2. **Segunda:** palpar los lados del útero para saber dónde está el dorso. Da la posición.
3. **Tercera** (maniobra de Pawlik): tomar la parte que se presenta sobre la sínfisis. Da la presentación y si está libre o encajada.
4. **Cuarta:** de frente a los pies de la paciente, deslizar las manos hacia la pelvis. Da el grado de **encajamiento** y la actitud.

4. Mecanismos del trabajo de parto (en orden)

Encajamiento → descenso → flexión → rotación interna → extensión → rotación externa (restitución) → expulsión.

Regla mnemotécnica: “**E**l **D**octor **F**ue **R**ápido **E**n **R**ealizar **E**l parto”. - **Encajamiento:** el diámetro biparietal (~9.5 cm) pasa el estrecho superior. Corresponde a la **estación 0**, a nivel de las espinas ciáticas. - **Rotación interna:** el occipucio gira hacia la sínfisis del pubis.

5. Etapas (periodos) del trabajo de parto

Periodo	Desde → hasta	Duración
1.º Dilatación, fase latente	Inicio de contracciones → **5 cm** (OMS 2018)	No se establece una duración estándar. Friedman la consideraba prolongada si pasaba de **20 h en nulíparas y 14 h en multíparas**
1.º Dilatación, fase activa	**5 cm → 10 cm**	Nulípara: en general **≤ 12 h**. Multípara: **≤ 10 h**
2.º Expulsivo	Dilatación completa → **nacimiento**	Mediana de 50 min en nulíparas y 20 min en multíparas. Límite: **3 h en nulíparas y 2 h en multíparas**; se suma 1 h con epidural
3.º Alumbramiento	Nacimiento → **expulsión de la placenta**	Normal hasta 30 min
4.º Puerperio inmediato	Primeras 2 h posparto	Vigilar la hemorragia

- **Velocidad de dilatación:**
  - La referencia práctica es de **≈ 1 cm/h** en la fase activa.
  - Friedman daba como mínimo normal 1.2 cm/h en nulíparas y 1.5 cm/h en multíparas.
  - No se usa la regla de 1 cm/h para decidir una intervención por sí sola.
- **Fase latente:** según Friedman termina a los 4 cm; según la OMS, a los 5 cm. En la fase latente no se hace amniotomía.
- **Descenso fetal:** empieza hacia los 7-8 cm en nulíparas.

6. Vigilancia en el trabajo de parto (bajo riesgo)

Parámetro	Frecuencia
Tacto vaginal	**Cada 4 h** en la fase activa, y además al romperse las membranas o si hay alteración de la FCF
FCF por auscultación intermitente, fase activa	**Cada 15-30 min**, durante 1 min y al terminar la contracción
FCF por auscultación intermitente, expulsivo	**Cada 5 min**
Temperatura, pulso y presión arterial	Cada 4 h. **Temperatura cada hora** si las membranas llevan rotas mucho tiempo
Contracciones	Frecuencia, duración e intensidad. Lo normal en la fase activa son **3-5 en 10 min**
Partograma	Dilatación, descenso de la presentación, FCF y signos vitales maternos

7. Lo que se recomienda y lo que no (GPC y OMS)

Se recomienda: - Acompañamiento continuo. - **Libre movilidad** y posición vertical en la fase activa. - **Líquidos claros** por vía oral. - Analgesia epidural si la paciente la solicita, y técnicas de relajación. - Auscultación intermitente en bajo riesgo. - Con epidural, **retrasar el pujo 1-2 h**. - En el expulsivo, **pujo espontáneo**, no dirigido. - Posición de nacimiento a elección de la mujer. - Protección del periné con compresas calientes y masaje perineal.

No se recomienda de rutina: - Enema. - Rasurado. - Pelvimetría. - Amniotomía. - Oxitocina para acelerar el trabajo de parto. - **Episiotomía**: solo se hace si está indicada. - Maniobra de **Kristeller** (presión del fondo uterino). - RCTG continuo en bajo riesgo. - Antibiótico profiláctico en el parto vaginal no complicado.

8. Tercer periodo: manejo activo del alumbramiento

1. **Oxitocina 10 UI IM** (o IV lenta) al salir el **hombro anterior** o justo después del nacimiento.
2. **Tracción controlada del cordón** con contratracción suprapúbica (maniobra de Brandt-Andrews).
3. **Masaje uterino** después del alumbramiento y vigilancia del tono uterino.

Pinzamiento del cordón: - Tardío, **al menos 60 s** (1-3 min), en recién nacidos que no requieran ventilación. - Es **inmediato** si hay: - desprendimiento de placenta; - placenta previa sangrante; - ruptura uterina; - desgarro del cordón; - paro cardiaco materno; - asfixia neonatal.

Signos de desprendimiento placentario: - Salida súbita de sangre. - El cordón se alarga (signo de Ahlfeld). - El útero sube y se vuelve globoso (signo de Schröeder). - El cordón no se retrae al presionar sobre el pubis (signo de Küstner).

Mecanismos de expulsión de la placenta: - **Schultze** (80 %): sale primero la cara fetal, brillante, y la sangre sale después. - **Duncan:** sale primero la cara materna, por el borde, con sangrado antes de la expulsión.

9. Atención inmediata del recién nacido

- **Contacto piel con piel** inmediato y **lactancia en la primera hora**.
- **Vitamina K 1 mg IM.**
- Profilaxis oftálmica.
- Baño diferido (no en las primeras horas).
- **Apgar** al 1.er y al 5.º minuto:

Signo	0	1	2
Aspecto (color)	Azul o pálido	Acrocianosis	Rosado
Pulso (FC)	Ausente	< 100 lpm	≥ 100 lpm
Gesticulación (reflejos)	Sin respuesta	Mueca	Llanto, tos
Actividad (tono)	Flácido	Cierta flexión	Movimiento activo
Respiración	Ausente	Lenta, irregular	Llanto fuerte

Interpretación del Apgar: 7-10 es normal; 4-6, depresión moderada; 0-3, depresión severa.

10. Oxitocina para conducción

	Valor
Inicio	**2 mU/min** (2-5 mU/min)
Incremento	**2 mU cada 15-30 min**
Máximo	**40 mU/min**
Objetivo	3-5 contracciones en 10 min. En Williams: 200-250 unidades Montevideo
Riesgos	Taquisistolia, hipertonía, ruptura uterina, intoxicación hídrica (efecto antidiurético)

Índice de Bishop: valora dilatación, borramiento, altura de la presentación (estación), consistencia y posición del cérvix. - **≥ 8:** cérvix favorable. - **≤ 6:** cérvix desfavorable; se necesita maduración cervical.

PARTE 2. RCTG (REGISTRO CARDIOTOCOGRÁFICO)

1. Cómo se lee: “DR C BRAVADO”

Definir el riesgo, **R**itmo y frecuencia de **C**ontracciones, **B**ase (FCF basal), **V**ariabilidad, **A**celeraciones, **D**eceleraciones y **O**pinión global.

2. Definiciones (NICHD/ACOG)

Parámetro	Normal	Anormal
FCF basal (promedio de 10 min)	**110-160 lpm**	Taquicardia > 160 lpm; bradicardia < 110 lpm
Variabilidad (amplitud)	**Moderada: 6-25 lpm**	Ausente: indetectable. Mínima: ≤ 5 lpm. Marcada: > 25 lpm
Aceleraciones	≥ 32 sem: **+15 lpm durante ≥ 15 s**. < 32 sem: +10 lpm durante ≥ 10 s	Ausencia (no es anormal por sí sola)
Contracciones	**≤ 5 en 10 min** (promedio de 30 min)	**Taquisistolia: > 5 en 10 min**

Duración de los cambios: - **Aceleración prolongada:** de 2 a 10 min. - **Cambio de basal:** si dura ≥ 10 min. - **Deceleración prolongada:** ≥ 15 lpm durante **2 a 10 min**.

3. Deceleraciones

Tipo	Forma	Relación con la contracción	Causa
Temprana	Gradual (≥ 30 s del inicio al nadir), en espejo	El nadir **coincide** con el pico de la contracción	**Compresión cefálica** (reflejo vagal). **Benigna**
Tardía	Gradual	El nadir ocurre **después** del pico; empieza y termina tarde	**Insuficiencia uteroplacentaria** (hipoxia)
Variable	**Abrupta** (< 30 s), forma de V, U o W; ≥ 15 lpm durante ≥ 15 s y < 2 min	Sin relación fija	**Compresión del cordón**
Prolongada	≥ 15 lpm durante 2-10 min	—	Hipotensión, taquisistolia, prolapso de cordón, desprendimiento

Recurrente significa que ocurre en **≥ 50 % de las contracciones** en una ventana de 20 min.

Regla mnemotécnica **VEAL CHOP**:

Patrón	Causa
Variable	**C**ompresión del cordón
Early (temprana)	**H**ead (compresión de la cabeza)
Aceleración	**O**K (oxigenación adecuada)
Late (tardía)	**P**lacenta (insuficiencia)

4. Clasificación en 3 categorías (NICHD 2008)

Categoría	Criterios	Significado y conducta
I, normal	Basal 110-160, variabilidad **moderada**, **sin** deceleraciones tardías ni variables. Las tempranas y las aceleraciones pueden estar o no	Feto bien oxigenado. **Vigilancia de rutina**
II, indeterminado	Todo lo que no es I ni III. Por ejemplo: taquicardia, variabilidad mínima o marcada, deceleraciones tardías o variables recurrentes con variabilidad conservada, deceleración prolongada, ausencia de aceleraciones tras estimulación	Es la categoría más frecuente (~73-80 %). **Reanimación intrauterina** y revalorar. La presencia de aceleraciones o de variabilidad moderada predice ausencia de acidemia
III, anormal	**Variabilidad ausente** más **cualquiera** de: deceleraciones tardías recurrentes, deceleraciones variables recurrentes o **bradicardia**. O bien **patrón sinusoidal** (3-5 ciclos/min durante ≥ 20 min)	Riesgo de acidemia. Reanimación intrauterina y **nacimiento inmediato** si no mejora, idealmente en **≤ 30 min**

Para la categoría III, la evidencia citada en UpToDate da: - pH < 7.0 en 31 %; - encefalopatía hipóxico-isquémica en 19 %; - Apgar < 7 a los 5 min en 14.6 %.

5. Reanimación intrauterina (categorías II y III)

1. **Decúbito lateral**, izquierdo o derecho. Si no funciona, posición de rodillas-pecho o “a cuatro patas”.
2. **Suspender la oxitocina** o los agentes de maduración.
3. **Tratar la taquisistolia.** Si persiste, **terbutalina 0.25 mg SC**.
4. **Corregir la hipotensión** materna, por ejemplo tras una epidural: líquidos IV y vasopresor (efedrina o fenilefrina).
5. **Tacto vaginal** para descartar **prolapso de cordón**, un descenso rápido o un parto inminente.
6. **Amnioinfusión** si hay deceleraciones variables recurrentes.
7. **Estimulación del cuero cabelludo fetal.** Si provoca una aceleración, el pH es > 7.20 con más de 90 % de probabilidad.
8. **Preparar el nacimiento** por la vía más rápida (cesárea o parto instrumentado) mientras se reanima.
9. El **oxígeno materno** no se recomienda de rutina. Puede usarse si hay hipoxemia materna.

6. Causas de alteraciones de la FCF

Alteración	Causas
Taquicardia (> 160 lpm)	**Fiebre materna o corioamnionitis**, hipoxia fetal inicial, fármacos (β-agonistas, atropina), hipertiroidismo, anemia fetal, arritmia
Bradicardia (< 110 lpm)	Hipoxia, **hipotensión materna**, prolapso de cordón, desprendimiento, ruptura uterina, **bloqueo cardiaco congénito** (lupus materno), descenso rápido
Variabilidad mínima o ausente	**Sueño fetal** (dura menos de 40 min), **opioides, sulfato de magnesio**, prematurez, acidemia
Patrón sinusoidal	**Anemia fetal grave** (isoinmunización Rh, hemorragia fetomaterna, vasa previa rota), hipoxia grave

7. Prueba sin estrés (PSS o NST, anteparto)

- **Reactiva: ≥ 2 aceleraciones** de 15 lpm durante 15 s en **20 min**. Se puede extender a 40 min por el ciclo de sueño fetal.
- **No reactiva:** no cumple los criterios en 40 min. Se continúa con un perfil biofísico o una prueba con contracciones.

8. Clasificación FIGO 2015 (equivalencias)

FIGO	Equivale a
Normal	Categoría I
Sospechoso	Categoría II
Patológico	Categoría III

9. Resumen rápido para el examen

Dato clave	Respuesta
FCF basal normal	**110-160 lpm**
Variabilidad normal	**6-25 lpm** (moderada)
Aceleración ≥ 32 semanas	+15 lpm durante 15 s
Deceleración por compresión cefálica	Temprana (benigna)
Deceleración por insuficiencia placentaria	Tardía
Deceleración por compresión del cordón	Variable
Patrón sinusoidal	Anemia fetal
Taquisistolia	> 5 contracciones en 10 min
Categoría III	Variabilidad ausente más deceleraciones recurrentes o bradicardia, o patrón sinusoidal
Primer paso ante una categoría II o III	Reanimación intrauterina: lateralizar, suspender la oxitocina, líquidos IV, tacto vaginal
Auscultación en el expulsivo	Cada 5 min
Auscultación en la fase activa	Cada 15-30 min